جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هند محمد محمود نصر
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** بولاق الدكرور **العنوان :** بولاق
رقم البطاقة : 27209162101283 **رقم التليفون :** 01126228737 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 16-09-1972 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: هند محمد محمود نصر
National ID: 27209162101283

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

05/24/2026

MDT FORM

Name:	Hand Mohamoud Mohamoud Nasr	**MRN:**	7852
Age:	54 Y	**ID:**	01126562495]]]]01126218737
Menopausal Sta	premenopausal (regular till 6 m ago)	**Phone:**	27209162101283
NRS SCORE:		**Marital Status:**	ز
BMI:		**Family History:**	+ve family history
CO Morbidity:	dm +htn+asthmatic	**Reason Of MDT:**	shift hormonal ttt

Clinical Data:

BX: idc

ER: 7/8 **PR:** 8/8 **HER2:** amplified **KI67:** 40-50%

Sonomammography:

Mets Workup:

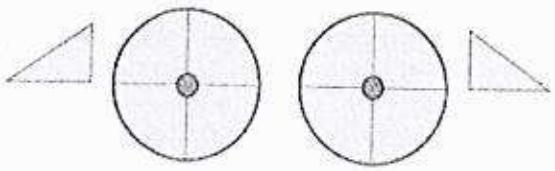
History:
2023 initial t4 n1 m0
received nacth tchp 27 weeks and hp *7cycles
6/2024 rt mrm (ppr, pt3 pn1/5 m0)
7/2024 adjuvant:kadcyla *12 cycles +porth +tamoxien 20 two years till now
(!!without zoladex)

in view of pt has multirisk factor for possibility to shift to ai

Recommendations:

MDT Outcome & Plan
for Femara zoladex+zometa /Gm

R L

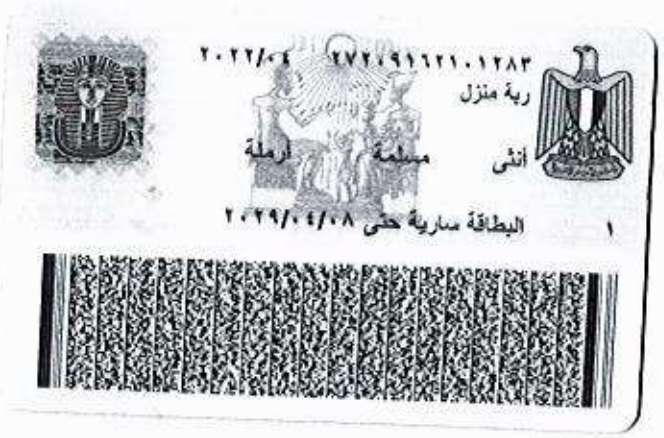


TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
Dr Hanan Ezzat	Dr Ahmed Naguib				







National ID · Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Name: هند محمد محمود نصر **MR. :** 7852	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed in 2023 with stage T4 N1 M0 breast cancer and received neoadjuvant chemotherapy with TAC (docetaxel, doxorubicin, cyclophosphamide) for 27 weeks, followed by 7 cycles of HER2-targeted therapy (trastuzumab) and radiotherapy to the left breast (RT MRM) in June 2024. The post-operative pathology showed pT3 pN1/5 M0. In July 2024 the patient commenced adjuvant therapy with 12 cycles of trastuzumab (Kadcyla) plus a port and tamoxifen 20 mg daily, continuing for two years without the use of a luteinizing hormone-releasing hormone agonist. The multidisciplinary team (MDT) has now shifted the patient to an aromatase inhibitor (AI) regimen.

In June 2026 the MDT recommended a combined endocrine and bone-protective strategy consisting of 6 months of zoladex (goserelin) plus femara (letrozole) and zoledronic acid, followed by 3 months of supportive care. The next scheduled visit is 11 October 2026. The patient has completed 6 months of zoladex + femara + zoledronic acid and 3 months of supportive care.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : نهي سعيد علي محمد

يعتمد ,

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

البرنامج الرئاسي لصحة المراة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:
1- Name : هلا محمد محمود نصر
Sex: Female
3- Medical number: 83160198
Old Med : 3256-2023
2-ID number: 27209162101283
Patient Age : 52 Y

MDT

Family history	Family History: +VE	Phone	Phone: 01126562495	BMI	BMI	REASON OF MDT	REASON OF MDT: POST OPERATIVE
marital status	Marital Status	NRS Score	NRS Score	GROUP	GROUP	Date of MDT	Date Of MDT: 13/07/2024
Co morbidity	Co Morbidity: DM,HTN	Menopausal status	Menopausal Status: PREMENOPAUSAL	Initial STAGE	Initial STAGE		

Clinical data

Breast Imaging :	Mets Workup :
	CTCAP-->BILOBER HFL LIKELY HEMANGIOMA MRI ABDOMEN-->NO HEPATIC METS BONE SCAN-->FREE

BX	ER	PR	Her 2 Neu	SISH	Ki67
IDC	7/8	8/8	2	Amplified	40-50
BX COMMENT	ER COMMENT	PR COMMENT	Her 2 Neu COMMENT	SISH COMMENT	

T	N	M
4D	1	0

Sonomammography

PATIENT HISTORY
pt rceived AC x4+TC x4+HP x1 but mild response
last MDT to continue 1 more TCHP
received TC x27+ HP x8

RT MRM :PPR, YPT3, YPN1(1/5)

MDT OUTCOME & PLAN

MDT OUTCOME & PLAN
in view of PPR
FOR ADJUVANT TDM1 *14 CYCLES
ADJUVNAT ET (ACCORDING TO E2, FSH)
PORT

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	MEDICAL ONCOLOGY: د/ ايمان حمدالله	RADIOLOGY	RADIOLOGY: د/ هبه فرج
SURGERY	SURGERY	PATHOLOGY	PATHOLOGY
Psychiatric	Psychiatric	Nutrition	Nutrition

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Cairo university –faculty of medicine
Cairo university hospital
Radiology department

جامعة القاهرة ـ كلية الطب
مستشفيات جامعة القاهرة
قسم الاشعة التشخيصية

Patient name english: HEND MOHAMED MAHMOUD	Age:
Study Date: 5/23/2023 12:11:46 PM	Patient id: 2352300001

OPINION:-

- Fatty hepatomegaly showing bilobar focal lesions with enhancement pattern as described? Hemangiomata, for ultrasound correlation and further assessment by triphasic CT/Dynamic MRI study.
- Bulky uterus with right adnexal cyst for ultrasound correlation.

Dr. Marie N. Grace MD

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Cairo university-faculty of medicine
Cairo university hospital
Radiology department

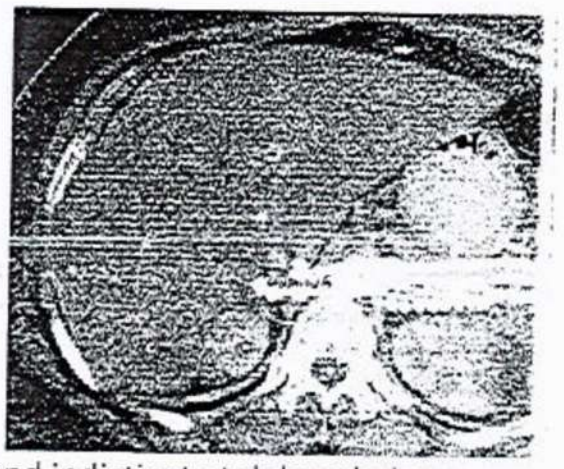
جامعة القاهرة كلية الطب
مستشفيات جامعة القاهرة
قسم الاشعة التشخيصية

Patient name english: HEND MOHAMED MAHMOUD	Age:
Study Date: 5/23/2023 12:11:46 PM	Patient id: 2352300001

GIT IMAGING UNIT

POST CONTRAST CT EXAMINATION OF ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-

**Known case of breast malignant process.



- Mild enlarged liver showing smooth outline and reduced parenchymal CT attenuation with right hepatic lobe segment VII focal lesion showing peripheral marginal nodular enhancement with progressive enhancement at delayed phase. It measures about 2.7 x2 cm at axial diameter. Another area/focal lesion with homogenous arterial enhancement is noted at left hepatic lobe segment IVa and indistinct at delayed phase.
- Patent portal vein and its branches.
- No dilated intra hepatic biliary radicles.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, IVC and aorta.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes
- Average filled urinary bladder with no masses or diverticular outpouching.
- No ascites or pelvic collection.
- Bulky uterus.
- Right adnexal uni-locular cyst seen measuring 4.4x3.8cm.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Cairo university –faculty of medicine
Cairo university hospital
Radiology department

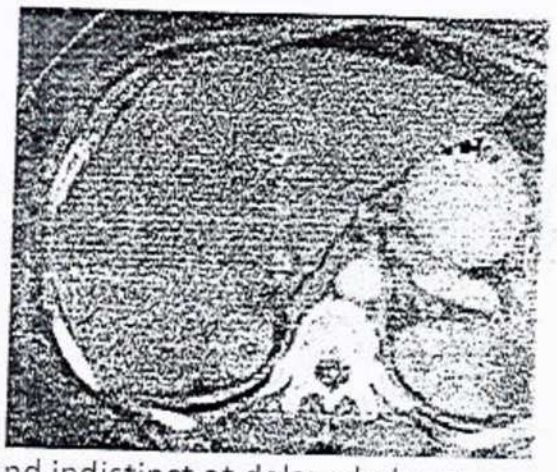
جامعة القاهرة -كلية الطب
مستشفيات جامعة القاهرة
قسم الاشعة التشخيصية

Patient name english: HEND MOHAMED MAHMOUD	Age:
Study Date: 5/23/2023 12:11:46 PM	Patient id: 2352300001

GIT IMAGING UNIT

POST CONTRAST CT EXAMINATION OF ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-

**Known case of breast malignant process.



- Mild enlarged liver showing smooth outline and reduced parenchymal CT attenuation with right hepatic lobe segment VII focal lesion showing peripheral marginal nodular enhancement with progressive enhancement at delayed phase. It measures about 2.7 x2 cm at axial diameter. Another area/focal lesion with homogenous arterial enhancement is noted at left hepatic lobe segment IVa and indistinct at delayed phase.
- Patent portal vein and its branches.
- No dilated intra hepatic biliary radicles.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, IVC and aorta.
- No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes
- Average filled urinary bladder with no masses or diverticular outpouching.
- No ascites or pelvic collection.
- Bulky uterus.
- Right adnexal uni-locular cyst seen measuring 4 4x3.8cm.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Patient Name	: الأستاذه / هند محمد محمود نصر شعراوى	Request No.	: 13005761
Patient No.	: 27209162101283	Request Date	: 12/06/2024
Path No.	: 2026/24	Verification Date	: 29/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - تأمين الدولة
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed yo

Pathology Report

- Maximal tumor diameter: 8x8 cm.
- Actual tumor cellularity: 20%.
- Resection Margins: Free.
- Skin: Free.
- Lymph nodes: Positive metastatic deposits in one out of five lymph nodes, L.N (1/5) (Diameter of nodal mets is 4 mm) (after repeated examination).
- Histologic response to therapy: Pathological partial response to therapy.
- Stage: ypT3, ypN1a.
- RCB: 3.509, RCB class-III.

Signature
Dr. Rana Fathy.
Dr. Marwa Mahmoud.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / هند محمد محمود نصر شعراوى	Request No.	: 13005761
Patient No.	: 27209162101283	Request Date	: 12/06/2024
Path No.	: 2026/24	Verification Date	: 29/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 51 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed yous

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.

Nature Specimen: Right modified radical mastectomy specimen.

Gross Examination:
* Procedure: Right MRM measured 27x20x5 cm, with covering skin ellipse measured 17x10 cm.
* Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
* Size: 8x8x3 cm.
* Skin: Nipple & areola looked unremarkable grossly.
* Distance from margins: 2 cm away from the deep margin.
* Lymph nodes: Only five L.Ns up to 0.5x0.5x0.5 cm, after repeated meticulous regrossing.

Microscopic Examination:
* Histological type: Residual viable invasive duct carcinoma.
* Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+2) Grade II.
- Maximal tumor diameter 8x8 cm.
- Actual tumor cellularity: 20%.
* Ductal carcinoma in situ: Not detected.
* Skin: Free.
* Resection Margins: Free.
* Lymph nodes: Positive metastatic deposits in one out of five lymph nodes, L.N (1/5) (Diameter of nodal mets is 4 mm), after repeated examination.
* Histologic response to therapy: Pathological partial response to therapy.

Diagnosis:
Right breast cancer post NACT, Right modified radical mastectomy specimen:
- Residual viable invasive duct carcinoma, Grade II.

Verified by :
Dr.Duaa Mohamed

غرفة رقم (4) – الدور الأول – مبنى رقم (987) – كورنيش النيل – مصر القديمة – القاهرة – مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]